JAZMI

JALINAN ZAMRUD ISLAMIAH

TRILOGI JAZMI · BUKU III

Akupresur Praktis

Tekanan aman dan batas yang jelas

Panduan keselamatan dan langkah dasar untuk pemula

III

Edisi 1 · 2026

qiladat.com

Tentang buku ini

Akupresur Praktis adalah Buku III dari Trilogi JAZMI, seri e-book tentang tiga arah dalam pengobatan tradisional: bekam, herbal dapur, dan akupresur. Tiga arah itu hanyalah alat bantu berpikir, bukan penggolongan medis baku.

Buku ini ditulis untuk pemula yang ingin memahami tekanan jari dengan benar, terutama demi diri sendiri dan keluarga. Urutannya sengaja dimulai dari siapa yang tidak boleh ditekan, bukan dari cara menekan.

CATATAN KESELAMATAN UTAMA

Buku ini bersifat edukasi. Isinya bukan diagnosis, bukan pengganti konsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan berizin, dan tidak menjanjikan kesembuhan. Akupresur tanpa jarum bukan berarti tanpa risiko: tekanan yang terlalu kuat atau di tempat yang keliru dapat menimbulkan nyeri, memar, dan memperburuk cedera. Gejala yang berat, mendadak, atau menetap adalah urusan pemeriksaan medis, bukan urusan titik tekan. Bila ada keraguan sekecil apa pun, tunda dan tanyakan dulu kepada tenaga kesehatan. Pembaca yang membawa kondisi medis, sedang hamil, atau memakai obat tertentu perlu berkonsultasi lebih dulu.

JAZMI — Jalinan Zamrud Islamiah
qiladat.com · YouTube @Qiladat · Instagram @jalinanzamrud

Edisi 1, 2026. Seluruh hak cipta dilindungi. Dilarang memperbanyak atau menjual ulang tanpa izin tertulis.

Daftar Isi

Cara Memakai Buku Ini 4
Bab 1 · Mengenal Akupresur: Apa Itu, dan Apa yang Bukan 5
Bab 2 · Siapa yang Tidak Boleh Ditekan 8
Bab 3 · Tangan, Kebersihan, dan Ruang 11
Bab 4 · Mengenal Tubuh secara Sederhana 13
Bab 5 · Langkah Praktik Dasar 15
Bab 6 · Area Latihan Hijau dan Satu Titik Bernama 19
Bab 7 · Sesudah Latihan dan Tanda Bahaya 23
Bab 8 · Menilai Klaim dan Kenali Batas Diri 26
Lembar Kerja 29
Lembar 1: Penapisan dan Persetujuan 30
Lembar 2: Daftar Periksa Persiapan 32
Lembar 3: Catatan Sesi 33
Lembar 4: Kartu Tanda Bahaya 34
Glosarium 35
Daftar Rujukan 36
Penutup 37

CATATAN

Buku ini memuat satu titik bernama saja (P6, Bab 6) dengan bukti dan batasnya. Titik lain sengaja tidak dimuat; alasannya dijelaskan di Bab 6. Empat lembar kerja di akhir buku bisa dicetak.

Cara Memakai Buku Ini

Baca berurutan. Bab 2 (siapa yang tidak boleh ditekan) sengaja datang sebelum bab praktik. Pembaca yang melompat langsung ke Bab 5 atau Bab 6 akan melewatkan bagian yang paling melindungi.

Apa yang dicakup

- Tekanan jari yang lembut pada kulit yang utuh, untuk orang dewasa yang sehat, di area latihan yang aman: diajarkan penuh (Bab 5 dan 6).
- Satu titik bernama, P6 di pergelangan tangan, dibahas bersama bukti, batas, dan peringatannya (Bab 6).
- **Tidak diajarkan:** tekanan kuat, memakai alat penekan atau benda keras, titik yang dikaitkan dengan persalinan, titik di leher, kepala, perut, dan dada, manipulasi sendi, serta akupunktur (jarum). Semua itu menuntut pelatihan langsung.

Tiga lapisan yang dipisahkan

Tiap kali akupresur dibicarakan, buku ini berusaha memisahkan tiga hal yang sering tercampur:

Lapisan	Artinya	Cara membacanya
Ajaran agama	Apa yang disebut dalam sumber-sumber keagamaan.	Akupresur berasal dari tradisi pengobatan Tiongkok, bukan dari sumber keagamaan. Buku ini tidak mengutip atau menafsirkan dalil; rujuklah ulama untuk prinsip berikhtiar.
Teori tradisional	Cara praktisi terdahulu menjelaskan titik, meridian, dan qi.	Bernilai sejarah, bukan bukti klinis.
Bukti modern	Hasil penelitian yang bisa diperiksa.	Dibaca dengan hati-hati: kualitas penelitian berbeda-beda.

Tanda yang dipakai

Kotak **Poin Kunci** merangkum bab. Kotak **Awas** menandai hal yang berisiko. Kotak **Coba Sendiri** mengajak Anda mempraktikkan atau merenungkan sesuatu. Di akhir buku ada Lembar Kerja yang bisa dicetak.

BAB 1

Mengenal Akupresur: Apa Itu, dan Apa yang Bukan

Sebelum belajar caranya, pahami dulu apa yang sebenarnya dilakukan akupresur, dan apa yang belum bisa dijanjikan.

Apa itu akupresur

Akupresur adalah pemberian tekanan manual dengan jari atau bagian tangan pada titik atau area tertentu di tubuh. Tidak ada jarum, tidak ada luka, dan tidak ada alat. Dalam kehidupan sehari-hari, orang menekan pelipis saat tegang atau memijat telapak tangan setelah bekerja. Tindakan seperti itu belum tentu akupresur dalam arti tradisional, tetapi menunjukkan bahwa sentuhan adalah bagian dari perawatan diri yang wajar.

Praktik	Cara umum	Ciri pembeda
Akupresur	Tekanan dengan jari atau tangan	Tanpa jarum; mengikuti peta titik tradisional
Akupunktur	Penusukan jarum tipis pada titik tertentu	Memerlukan pelatihan serta prosedur kebersihan dan keselamatan
Pijat	Usapan, remasan, atau tekanan pada jaringan	Dapat mencakup area luas, tidak selalu mengikuti peta titik
Peregangan	Gerakan untuk memanjangkan otot	Berfokus pada gerakan, bukan tekanan titik

Asal-usul dan kerangka tradisional

Akupresur modern banyak berakar pada pengobatan tradisional Tiongkok, yang juga melandasi akupunktur. Dalam tradisi itu tubuh dipetakan lewat jalur yang disebut **meridian** dan titik-titik di sepanjangnya, dan kesehatan dipahami sebagai keseimbangan aliran **qi**.

Konsep meridian dan qi adalah sistem penjelasan historis dan filosofis. Keduanya tidak identik dengan saraf, pembuluh darah, atau struktur lain yang dikenal ilmu

kedokteran modern. Itu tidak berarti seluruh praktiknya pasti sia-sia; artinya, sejarah sebuah teknik berbeda dari bukti bahwa teknik itu bekerja.

Bagaimana akupresur diduga bekerja

Belum ada satu penjelasan yang disepakati. Beberapa gagasan yang diajukan:

- **Rangsang sensorik:** tekanan pada kulit dan otot dapat mengubah cara tubuh menafsirkan nyeri dan ketegangan.
- **Relaksasi:** sentuhan yang tenang dapat menurunkan ketegangan.
- **Perhatian dan harapan:** ritual, rasa diperhatikan, dan keyakinan ikut memengaruhi apa yang dirasakan.

Ketiganya masih berupa dugaan. Menyebutnya sebagai kepastian akan berlebihan.

Apa kata bukti

Bukti terkuat yang kerap dibahas ialah rangsangan titik **P6** di pergelangan tangan untuk mual dan muntah **setelah operasi**. Tinjauan Cochrane atas puluhan uji klinis melaporkan bahwa rangsangan P6 (dengan berbagai cara, termasuk tekanan) mengurangi risiko mual dan muntah dibanding perlakuan pura-pura, dengan efek samping yang umumnya ringan. Namun, penelitian itu mencampur banyak cara perangsangan (jarum, listrik, gelang tekan, dan lainnya), mutu uji-ujinya bervariasi, dan versi terbarunya menilai keyakinan terhadap sebagian hasil hanya sedang sampai rendah.

Hasil itu tidak dapat otomatis dipindahkan ke mual karena sebab lain, apalagi ke keluhan lain. Untuk nyeri, gangguan tidur, kecemasan, dan keluhan lain, bukti yang ada umumnya terbatas atau beragam kualitasnya. Kesimpulan yang jujur: **mungkin membantu sebagian orang pada sebagian keluhan, tetapi belum terbukti kuat dan jelas bukan obat penyakit.** Siapa pun yang menjanjikan kesembuhan penyakit lewat titik tekan sedang melampaui bukti.

Mitos dan fakta

Yang sering dikatakan	Yang lebih tepat
“Satu titik menyembuhkan satu penyakit.”	Tidak ada bukti yang kuat untuk klaim itu. Bukti terbatas pada beberapa keluhan, dan itu pun beragam.
“Makin sakit ditekan, makin manjur.”	Keliru. Nyeri tajam adalah tanda untuk mengurangi tekanan, bukan tanda keberhasilan.
“Titik yang nyeri menunjukkan organ yang sakit.”	Tidak terbukti. Nyeri saat ditekan dipengaruhi banyak hal: ototnya, kebiasaan menekan, dan kepekaan.
“Tanpa jarum pasti aman.”	Tidak selalu. Tekanan keliru dapat memar, melukai jaringan, atau menunda penanganan yang dibutuhkan.
“Kalau terasa enak, berarti sudah menyembuhkan.”	Rasa nyaman nyata, tetapi belum membuktikan penyakit teratasi.

POIN KUNCI

- Akupresur adalah tekanan manual tanpa jarum. Peta meridian dan qi adalah teori tradisional, bukan anatomi modern.
- Bukti terkuat: P6 untuk mual-muntah pascaoperasi. Untuk keluhan lain, terbatas dan beragam.
- Sejarah panjang dan testimoni bukan bukti klinis. Pisahkan ajaran agama, teori tradisional, dan bukti modern.

COBA SENDIRI

Tulis tiga hal yang pernah Anda dengar tentang akupresur atau “titik”. Tandai mana yang teori tradisional, mana yang pengalaman orang, dan mana yang punya bukti penelitian. Sering kali ketiganya tercampur tanpa disadari.

BAB

2 Siapa yang Tidak Boleh Ditekan

Keselamatan dimulai dari memutuskan kapan akupresur tidak dilakukan. Bab ini paling penting untuk dibaca pelan-pelan.

Tiga warna penapisan

Sebelum menekan siapa pun, tanyakan hal-hal berikut. Jawaban dikelompokkan seperti lampu lalu lintas:

Warna	Artinya	Tindakan
MERAH	Risiko tinggi atau tidak boleh	Jangan menekan. Sarankan periksa ke dokter.
KUNING	Perlu kehati-hatian khusus	Tunda sampai ada izin dari dokter atau pembimbing berpengalaman.
HIJAU	Tidak ada kondisi di atas	Boleh lanjut dengan hati-hati, mulai dari yang paling ringan.

Daftar MERAH: jangan menekan

Jika salah satu jawaban berikut adalah “ya”, jangan lanjutkan.

- Ada **gejala darurat**: nyeri dada, sesak napas, kelemahan satu sisi tubuh, gangguan bicara, sakit kepala hebat mendadak, atau penurunan kesadaran. Cari pertolongan darurat sekarang.
- Ada luka terbuka, infeksi kulit, ruam yang sedang aktif, kulit terbakar matahari, atau iritasi berat di area yang akan ditekan.
- Ada cedera baru, memar baru, bengkak yang belum jelas penyebabnya, atau dugaan patah tulang atau sendi terkilir.
- Ada nyeri berat, atau nyeri yang disertai kebas, lemah, atau menjalar, yang belum diperiksa dokter.
- Ada benjolan yang belum jelas penyebabnya, varises yang menonjol, atau riwayat gumpalan darah di area itu.
- Punya gangguan pembekuan darah yang diketahui (misalnya hemofilia).

- Demam, infeksi akut, dehidrasi, atau sedang sakit dan sangat lemah.
- Menderita kanker atau sedang menjalani terapi kanker (tanyakan dulu kepada dokter yang merawat).
- Berusia di bawah 18 tahun. Buku ini hanya untuk orang dewasa.

Daftar KUNING: tanya dulu

Jawaban "ya" di sini bukan berarti selamanya tidak boleh, tetapi pemula sebaiknya tidak memutuskan sendiri.

- **Sedang hamil** atau mungkin hamil. Tanyakan kepada bidan atau dokter, dan jangan mencoba titik yang diklaim memicu kontraksi.
- Diabetes (luka sembuh lebih lambat, rasa di kaki bisa berkurang).
- Memakai obat pengencer darah, atau kulit mudah memar.
- Tekanan darah tinggi atau penyakit jantung.
- Tulang rapuh (osteoporosis), atau berusia lanjut dengan kulit tipis.
- Gangguan rasa di kulit atau saraf yang membuat tekanan sulit dinilai.
- Pernah pingsan, mudah pusing, atau punya epilepsi.
- Kulit sangat sensitif atau mudah membentuk keloid.
- Nyeri atau keluhan lama yang belum pernah diperiksa.
- Sangat cemas, atau tidak nyaman dengan sentuhan.
- Minum obat rutin yang belum diketahui pengaruhnya.

Hari ini: kondisi saat itu

Orang yang sehat pun tidak selalu cocok ditekan pada hari tertentu. Tunda bila:

- Demam atau merasa akan jatuh sakit.
- Sangat lapar, atau baru makan dalam porsi besar.
- Kurang tidur parah atau sangat letih.
- Sedang dalam pengaruh alkohol atau obat penenang.

Persetujuan

Bila Anda menekan orang lain, jelaskan dengan bahasa sederhana apa yang akan dilakukan, rasa yang wajar (tertekan, hangat), bahwa tekanan tidak akan dibuat sakit, dan bahwa orangnya boleh meminta berhenti kapan saja. Sentuhan hanya di area yang disepakati, tanpa menyentuh area pribadi. Tanpa persetujuan yang paham, jangan mulai.

Alur keputusan

Pertanyaan	Jika YA
Mulai: isi Lembar 1 bersama orang yang akan ditekan.	Lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Ada jawaban YA pada daftar MERAH?	**BERHENTI.** Jangan menekan. Sarankan periksa ke dokter.
Ada jawaban YA pada daftar KUNING?	**TUNDA.** Tanyakan dulu ke dokter atau pembimbing.
Ada kondisi hari ini yang tidak baik?	**TUNDA** ke hari lain.
Orangnya belum paham, belum setuju, atau tidak boleh berhenti kapan saja?	**JANGAN** lanjut tanpa persetujuan.
Semua di atas TIDAK.	**Boleh lanjut**, dengan hati-hati, mulai dari yang paling ringan.

POIN KUNCI

- Satu jawaban YA pada daftar MERAH sudah cukup untuk berhenti. Jangan membujuk; sarankan periksa.
- Penapisan dilakukan setiap kali, bukan sekali seumur hidup. Kondisi orang bisa berubah.
- Gejala darurat tidak ditangani dengan titik tekan.
- Bila ragu, jawabannya adalah tunda. Lembar 1 di akhir buku adalah formulir penapisan yang bisa dicetak.